

إسم المريض رابعياً : انتصار النويش دكروری علی

الحى / المدينة : الحيزه

المحافضة : الحيز ه

رقم البطاقة : 26906222100108 رقم التلفون : 01117934132

العمر(تاريخ الميلاد) : 22-06-1969 المهنة : ربه منزل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

**قسم العلاج :
الاورام**

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتاز [14161]

----- التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

التوقيع:

التوقيع:

التوقيع:

تتعمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

----- / ۲ ----- / ۲ ----- / ۲.۱ ----- / ۲.۱

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جھة العلاج :-

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشؤون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: انتصار النويش دكروري علي National ID: 26906222100108	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Ministry of health
Central health laboratories
Pathology department

ImmunohistoChemistry report

Report Number: m2972

Female	النوع	إنتصاب التوتش دكرورى على	اسم المريض
القاهرة	العلوى	51 Y	السن
04/06/2020 11:59	تاريخ استلام العينة	مركز أورام دار السلام	تاريخ أخذ العينة
11/06/2020 13:12	تاريخ التقرير	مركز أورام دار السلام	طالب التحليل
			عناية

Primary Sample :

Paraffin Block

Test :

ER & PR & HER2 neu & Ki67 (ER&PR: Harvey scoring system -Her2neu : CAP scoring system)

Comment :

Technique :

sample received was treated by : - CONFIRM anti-estrogen (ER) (SP1) Rabbit monoclonal primary antibody. - CONFIRM anti-progesterone receptor (PR) (IE2) Rabbit monoclonal primary antibody.
Sample received was treated by : - VENTANA anti-HER2/neu (4B5) Rabbit monoclonal primary antibody using DAB Detection kit in ventana benchmark GX.
Sample received was treated by : - CONFIRM anti Ki67 (30-9) Rabbit monoclonal primary antibody.

Result :

ER: moderate nuclear staining of > 60 % of tumour cells
PR: No nuclear staining of tumour cells
HER2/neu protein over expression : faint discontinuous membrane staining of tumor cells
Ki67: positive nuclear staining of 40-50 % of tumour cells

Referral Lab :

Comment :

Conclusion :

R: POSITIVE (SCORE 7/8)
R: NEGATIVE
HER2NEU PROTEIN OVER EXPRESSION : NEGATIVE (SCORE 1+)
Ki67: THE PROLIFERATION INDEX OF THE TUMOUR IS 40-50 %

Pathologist:

د/نزيها ماهر

Lab Director: د/نزيها ماهر

116

2020

5 El-shekh Rehan Street, Abdeldeen, Cairo
tel: (165) 794854 - 7950096 Fax: (202) 7948544
toll-free: 01144297292
website: http://www.hsalhlab.net
mail: pathology@hsalhlab.com
facebook: قسم التشريحي - الإدارة المركزية للمعامل

This Test is Not Accredited By EGAC Nor Recognized By ILA

يتم الاعطاء ماسل العينة لمدة 30 يوم من تاريخ استلامها

Page 1 of 1

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Name: انتصار النويشي ذكروري علي			
MR. : 6191			
Detailed Medical Report			
		السيد	
تجبة طبية وبعد,,			
إيماء للطلب المقدم من		بشأن تقرير طبي للمريض	
بقسم:		رقم طبي:	
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient is a 56-year-old individual with a history of left-sided breast invasive ductal carcinoma, grade II, estrogen-receptor (ER) score 8/8, progesterone-receptor (PR) score 3/8, and HER2-positive (2+). The patient underwent left modified radical mastectomy (MRM) in April 2020, with pathology reported as T2N1, 1 of 15 lymph nodes positive, and 4/4 positive for tumor cells on immunohistochemistry. HER2 amplification was confirmed, and adjuvant therapy with trastuzumab (Herceptin) and tamoxifen was initiated in October 2020, followed by an aromatase inhibitor (AI) in January 2023. The patient also received calcium supplementation (1 × 1 × 90) and a single dose of Femara. The patient did not undergo a recent skeletal survey (SM) or chest computed tomography (CT) for new assessment. The current plan is to continue monitoring and consider appropriate imaging when clinically indicated.			
تحريرا في ,			
التاريخ :		19-09-2026	
الوقت :		ايه مدحت بدوي محمد	
الطبيب المعالج :			
يعتمد ,			

PATIENT NAME: ANTSAR Elnohy Dakrory ALI
GENDER: Female
AGE: 50 y

PATIENT ID #: 2020122056
ORDER #: 739521
DATE OF SERVICE: 16-Jun-2020 01:55 PM

Report:

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information: -
skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner:

Report:

No hot spot that account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.

Degenerative changes are seen over dorso-lumbar vertebrae.

Arthritic changes are seen over both knees.

Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed

16-Jun-2020 02:44 PM

PATIENT NAME: ANTSAR Elnoahy Dakrory ALI

GENDER: Female

AGE: 50 y

PATIENT ID #: 2020122056

ORDER #: 739521

DATE OF SERVICE: 16-Jun-2020 01:55 PM

Report:

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information: -
skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner:

Report:

No hot spot that account for osseous deposits could be detected all over the surveyed skeleton.

Degenerative changes are seen over dorso-lumbar vertebrae.

Arthritic changes are seen over both knees.

Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed

16-Jun-2020 02:44 PM

PATIENT NAME: ANTAR Elmshy Dakrory ALI
GENDER: Female
AGE: 50 y

PATIENT ID #: 2020122056
ORDER #: 715717,715718
DATE OF SERVICE: 23-Mar-2020 03:11 PM

Report: • all studies

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS**

1. CHEST

- Left breast retro-areolar irregular mass seen measuring 30 x 20 mm in its maximum axial diameters.
- Ipsilateral enlarged axillary lymph nodes are noted, the largest is seen measuring 26 x 17 mm in its maximum axial diameters.
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. ABDOMEN AND PELVIS

- Enlarged liver with homogenous low CT attenuation. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and right suprarenal gland.
- Relatively bulky left suprarenal gland.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular

- outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.
- The scanned skeleton is unremarkable apart from spondylodegenerative changes.

Opinion:

- Left breast retro-areolar irregular mass with ipsilateral enlarged axillary lymph nodes, for Sono-mammographic correlation.
- Fatty hepatomegaly.

Reported By,

Dr. Kareem Moussa, MD
Dr. Samar Ahmed, MSc

23-Mar-2020 07:05 PM